Escalas de Valoración Más Usadas

Resumen de escalas clínicas de uso frecuente en fisioterapia

Escala Visual Analógica (EVA)

Qué mide: Intensidad subjetiva del dolor percibida por el paciente.

Cuándo usarla: En cada sesión de fisioterapia para monitorear el dolor antes y después del tratamiento.

Cómo se aplica: El paciente marca su dolor en una línea de 10 cm (0 = sin dolor, 10 = peor dolor imaginable).

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
0	Sin dolor
1–3	Dolor leve
4–6	Dolor moderado
7–10	Dolor severo

Escala de Daniels / MRC (Fuerza Muscular)

Qué mide: Fuerza muscular mediante prueba manual contra gravedad y resistencia.

Cuándo usarla: Valoración inicial y seguimiento en pacientes con debilidad muscular, lesiones neuromusculares o posquirúrgicos.

Cómo se aplica: El fisioterapeuta evalúa la capacidad del músculo para mover el segmento contra gravedad y resistencia.

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
0	Sin contracción visible
1	Contracción visible sin movimiento
2	Movimiento completo sin gravedad
3	Movimiento completo contra gravedad
4	Movimiento contra resistencia moderada
5	Fuerza normal

Escala de Ashworth Modificada

Qué mide: Grado de espasticidad (resistencia al movimiento pasivo).

Cuándo usarla: Pacientes con lesión de neurona motora superior: enfermedad cerebrovascular, lesión medular, parálisis cerebral, esclerosis múltiple.

Cómo se aplica: El evaluador mueve pasivamente la extremidad y califica la resistencia encontrada.

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
0	Sin aumento del tono muscular
1	Leve aumento al final del arco
1+	Leve aumento en menos de la mitad del arco
2	Aumento marcado en la mayor parte del arco
3	Aumento considerable, movimiento pasivo difícil
4	Segmento rígido en flexión o extensión

Escala de Berg (Equilibrio)

Qué mide: Equilibrio funcional estático y dinámico en adultos.

Cuándo usarla: Pacientes con riesgo de caídas, adultos mayores, pacientes neurológicos y posquirúrgicos de miembro inferior.

Cómo se aplica: 14 tareas funcionales puntuadas de 0 a 4 cada una. Puntuación máxima: 56 puntos.

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
0–20	Alto riesgo de caídas (silla de ruedas)
21–40	Riesgo moderado (asistencia para la marcha)
41–56	Bajo riesgo de caídas (independiente)

Escala de Tinetti (Equilibrio y Marcha)

Qué mide: Equilibrio y marcha; predice riesgo de caídas en adultos mayores.

Cuándo usarla: Evaluación geriátrica, pacientes con alteraciones de la marcha, prevención de caídas.

Cómo se aplica: Dos secciones: equilibrio (16 puntos) y marcha (12 puntos). Total máximo: 28 puntos.

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
<19	Alto riesgo de caídas
19–24	Riesgo moderado de caídas
25–28	Bajo riesgo de caídas

Índice de Barthel (Independencia Funcional)

Qué mide: Nivel de independencia en actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Cuándo usarla: Pacientes con dependencia funcional: enfermedad cerebrovascular, lesión medular, adultos mayores, rehabilitación posquirúrgica.

Cómo se aplica: 10 actividades evaluadas (alimentación, baño, vestido, aseo, continencia, traslados, deambulación, escaleras). Puntuación máxima: 100.

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
0–20	Dependencia total
21–60	Dependencia severa
61–90	Dependencia moderada
91–99	Dependencia leve
100	Independencia

Escala de Coma de Glasgow

Qué mide: Nivel de conciencia tras lesión cerebral o alteración neurológica.

Cuándo usarla: Emergencias, trauma craneoencefálico, monitoreo neurológico. No es de uso exclusivo del fisioterapeuta, pero debe conocerla.

Cómo se aplica: Tres componentes: apertura ocular (1–4), respuesta verbal (1–5), respuesta motora (1–6). Puntuación total: 3–15.

Interpretación general:

Puntuación / Grado	Interpretación
3–8	Lesión grave (coma)
9–12	Lesión moderada
13–15	Lesión leve

Nota: *Esta guía resume el propósito e interpretación general de cada escala. No se reproducen los reactivos completos. Consulta las fuentes originales y la capacitación correspondiente para su aplicación correcta.*

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.